

Occlusion intestinale aiguë

Table des matières

Objectifs pédagogiques:.....	1
I.Définition.....	1
II.Mécanismes.....	1
III.Etude sémiologique	2
➤ Reconnaître l'occlusion:.....	2
Signes fonctionnels :.....	2
Signes physiques :.....	2
Examens complémentaires :	3
➤ Le siège de l'occlusion:	3
➤ La cause de l'occlusion:.....	3
IV. Conclusion.....	4
Bibliographie	4

Objectifs pédagogiques:

1. Connaître les signes d'une occlusion intestinale aiguë
2. Citer les causes de l'occlusion intestinale aiguë

I.Définition

L'occlusion intestinale aiguë : obstruction mécanique ou fonctionnelle de l'intestin, siégeant au niveau du côlon ou du grêle, s'accompagnant d'une gêne au transit intestinal. L'occlusion intestinale mécanique est toujours une Urgence chirurgicale.

II.Mécanismes

a) L'occlusion intestinale aiguë mécanique : 2 mécanismes : par strangulation et par obstruction.

— Occlusion par strangulation : il s'agit d'un obstacle qui entraîne une strangulation due à :

- Une bride : cicatrice fibreuse secondaire à une intervention chirurgicale.
 - Un volvulus : torsion de l'intestin sur lui-même.
 - Un étranglement herniaire : cause la plus fréquente des occlusions par strangulation, la hernie contient de l'épiploon et de l'intestin.
- Occlusion par obstruction de la lumière intestinale: la cause la plus fréquente est une tumeur intestinale.
- b) L'occlusion intestinale fonctionnelle : peut survenir :
- Au cours d'une péritonite aiguë, l'occlusion est alors réflexe.
 - En cas de déséquilibre hydro-électrolytique s'accompagnant d'hypokaliémie.

III. Etude sémiologique

Occlusion intestinale mécanique : l'étude sémiologique a pour but de reconnaître l'occlusion, d'en préciser le siège et de retrouver si possible la cause.

➤ Reconnaître l'occlusion: sur des caractères communs réalisant le syndrome occlusif.

Signes fonctionnels : à l'interrogatoire: une triade fonctionnelle caractéristique:

1-douleur abdominale :

-dont le mode de début est variable ainsi que l'intensité,

-À type de coliques intermittentes évoluant par paroxysmes témoins de la lutte de l'intestin contre l'obstacle, entre les paroxysmes persiste un fond douloureux permanent;

2-vomissements : plus ou moins précoces d'abord alimentaires, puis bilieux et enfin fécaloïdes dans les formes négligées;

3-l'arrêt des matières et des gaz : est le signe fondamental ; l'arrêt des gaz est constant, il précède l'arrêt des matières de quelques heures.

Signes physiques : l'examen clinique va mettre en évidence le météorisme abdominal qui est visible, palpable et percutable.

-inspection : met en évidence :

*le météorisme abdominal ou ballonnement abdominal qui est généralisé ou localisé ;

*parfois existence de mouvements péristaltiques visibles sous la peau qui peuvent être déclenchés par une chiquenaude

*enfin, elle recherche une cicatrice d'intervention chirurgicale;

-palpation :

*montre une sensation de résistance élastique,

*elle contrôle l'absence de contracture abdominale,

*elle peut noter une sensation de durcissement intermittent qui est en rapport avec les ondulations péristaltiques,

*enfin elle permet de vérifier les orifices herniaires à la recherche d'une hernie étranglée;

- percussion : met en évidence un tympanisme généralisé ou localisé;

- l'auscultation : va retrouver soit un silence abdominal, soit au contraire des bruits hydro-aériques et des gargouillements spontanés ou provoqués; - les touchers pelviens : TR et TV sont en règle normaux.

Examens complémentaires : l'ASP va montrer un signe fondamental : l'existence de niveaux hydro-aériques.

➤ Le siège de l'occlusion: sera reconnu sur des signes particuliers, il peut s'agir : d'une occlusion du grêle ou d'une occlusion du côlon.

1*Occlusion du grêle : début brutal

- Signes fonctionnels :
 - douleurs abdominales à début brutal et très intenses,
 - vomissements intenses et précoces ;
 - arrêt des matières et des gaz tardif;
 - altération de l'état général importante, il existe un tableau de déshydratation d'installation rapide qui peut aboutir au collapsus par hypovolémie.
- Signes physiques : le météorisme abdominal est localisé, central dans la région périombilicale et il est discret.
- Signes radiologiques : l'ASP montre : des niveaux hydro-aériques nombreux, de petites dimensions, réalisant des images étagées « en tuyaux d'orgue », absence de distension colique

2* Occlusion du côlon : début progressif

- Signes fonctionnels :
 - douleurs abdominales à début progressif, d'intensité peu marquée;
 - vomissements tardifs;
 - arrêt des matières et des gaz précoce;
 - l'état général est longtemps conservé.
- Signes physiques : le météorisme abdominal est très important,
 - soit périphérique en cadre,
 - soit asymétrique, puis il devient diffus et généralisé.
- Signes radiologiques : l'ASP montre: une distension gazeuse du cadre colique et des images hydroaériques peu nombreuses.

➤ La cause de l'occlusion: on peut opposer :

a) L'occlusion par strangulation : réalise un tableau à début brutal et d'une grande gravité à l'occlusion par obstruction qui au contraire réalise un tableau à début progressif et moins alarmant, mais en fait le diagnostic précis est apporté par la laparotomie exploratrice qui est de toute façon le geste indispensable dès que le diagnostic d'occlusion intestinale aiguë est porté.

b) L'occlusion intestinale fonctionnelle: ou iléus paralytique : est due à une paralysie de l'intestin; reconnue sur les signes suivants :

- Signes fonctionnels : arrêt des matières, sans arrêt absolu des gaz, la douleur est peu importante, voire absente.

- Signes physiques : météorisme abdominal diffus, immobile, sans ondulations péristaltiques.
- Signes radiologiques : l'ASP montre: une distension intestinale globale intéressant également le cadre colique sans niveaux hydro-aériques.

IV. Conclusion

L'occlusion intestinale est une urgence abdominale pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient par son évolution. Elle exige donc un diagnostic précoce. La douleur abdominale est le maître symptôme, seuls un interrogatoire et un examen clinique soigneux aidés des examens complémentaires permettent de poser le diagnostic précoce.

Bibliographie

R.M Hamladji, Précis de sémiologie, OPUALGER.